UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Trabalho Final de Graduação I

ENSAIO CONCEITUAL - AC03

Centro comunitário com moradia transitória: recuperação do transtorno do jogo e educação financeira aberta a todos

Docentes: Stavros Wrobel Abib e Carolina Rocha Carvalho

Balneário Camboriú, SC
2026.2

1. Delimitação do tema e do fenômeno

O trabalho se encontra na área de equipamento comunitário e de assistência social, focando no transtorno do jogo e educação financeira aberta a todos. “O Transtorno do Jogo (TJ) é uma dependência comportamental caracterizada por comportamentos repetitivos e persistentes relacionados a apostas que causam prejuízos significativos na vida pessoal, social e profissional do indivíduo” (LARANJEIRA; MADRUGA, 2025, p. 21). Sabe-se também que indivíduos em precariedade financeira ficam mais vulneráveis à ilusão de ganhos rápidos (LARANJEIRA; MADRUGA, 2025, p. 51). O cuidado deve reconhecer que os impactos das apostas vão além do indivíduo e da saúde mental. Eles refletem desigualdades sociais, econômicas e culturais, exigindo ações locais, integradas, pautadas na escuta e na responsabilidade coletiva (BRASIL, 2026, p. 11). Atualmente a ajuda vem pelo SUS, mas o cuidado se distribui entre os serviços da RAPS. O Ministério da Saúde reconhece a urgência de organizar a rede (BRASIL, 2025a, p. 3). No entanto, o Tribunal de Contas da União constata que falta espaço físico (BRASIL, 2025b, p. 49). Esse cenário configura uma fragmentação espacial do cuidado, distribuído entre serviços e lugares diferentes. Como resposta, este trabalho propõe a tipologia de um centro comunitário com moradia transitória. De que modo o espaço pode reunir esse cuidado, hoje fragmentado, em um lugar de acolhimento, convivência, moradia, encaminhamento e educação financeira?

2. Justificativa

Estima-se que 7,3% dos brasileiros com 14 anos ou mais têm comportamentos que se alinham às diretrizes de jogo de risco ou problemático, o que representa cerca de 10,9 milhões de pessoas, e cerca de 1,4 milhão de brasileiros apresentam pontuação compatível com diagnóstico provável de Transtorno do Jogo (LARANJEIRA; MADRUGA, 2025, p. 40). A relevância deste trabalho está em apresentar a educação financeira e prevenção para as pessoas em situação de risco, e acolhimento e recuperação às pessoas com provável transtorno. A Nota Técnica nº 4/2025 do Ministério da Saúde atribui aos Centros de Convivência as seguintes ações: “direito à cultura e cidadania: Ofertar atividades culturais; ofertar

ações de geração de trabalho e renda; promover ações de integração da população e território” (BRASIL, 2025a, p. 8). Ao CAPS, a nota recomenda “realizar orientações sobre educação financeira básica e endividamento, em parceria com serviços de assistência social” (BRASIL, 2025a, p. 9). Às Unidades de Acolhimento, a nota atribui “ofertar local de moradia transitória para pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar e que demandem acolhimento terapêutico e protetivo com relação aos jogos de aposta por até 6 meses” (BRASIL, 2025a, p. 9). Embora essas ações estejam previstas, elas estão distribuídas entre serviços diferentes. Além disso, o TCU aponta que as unidades, de modo geral, não possuem estrutura suficiente para atender ao crescente número de pessoas com o transtorno, com carência de profissionais especializados e de espaço físico (BRASIL, 2025b, p. 49). Nas pesquisas levantadas, no contexto brasileiro, não foi identificado um equipamento que associe, em um mesmo espaço e vinculado à rede do SUS, a prevenção aberta à população, com educação financeira, à recuperação, à moradia transitória e à geração de trabalho e renda para pessoas com transtorno do jogo e endividamento. A contribuição deste trabalho é reunir essas funções em um único espaço. Nesse espaço, pessoas em recuperação podem atuar profissionalmente e orientar aqueles que estão chegando ao tratamento.

3. Objetivos

3.1 OBJETIVO GERAL

Projetar um centro comunitário com moradia transitória, destinado a pessoas em recuperação do transtorno do jogo e a pessoas em situação de jogo de risco.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Planejar a moradia transitória de modo a favorecer o afastamento do ambiente de risco e a autonomia gradual de quem está em recuperação.
- Conceber os espaços abertos de educação financeira para acolher o público em geral sem distinguir quem está em recuperação de quem não está.
- Articular espaços de trabalho e renda, incluindo os comércios do próprio centro, nos quais quem está em recuperação gera renda e quem já se recuperou atua profissionalmente e orienta quem chega.

- Elaborar a relação do edifício com a cidade, de modo a permitir o acesso direto, sem encaminhamento prévio, e a articulação com a rede de saúde.

4.Recorte da revisão de literatura

As fontes analisadas discutem o jogo como problema coletivo, o papel do ambiente e os modelos de moradia para recuperação.

O relatório da Comissão da Lancet sobre o jogo, elaborado por uma comissão internacional de especialistas em saúde pública, aponta que “a maioria das soluções políticas para os danos do jogo se baseia na noção de responsabilidade individual” e que enquadrar o problema dessa forma desvia a atenção das práticas da indústria e do comportamento corporativo (WARDLE et al., 2024, p. e950). Esse diagnóstico converge com o Ministério da Saúde brasileiro, segundo o qual as políticas públicas “deverão ultrapassar a individualidade do problema e seguir para uma abordagem coletiva e de saúde pública” (UKHOVA et al., 2024 apud BRASIL, 2026, p. 10).

Essa visão é reforçada por Blaszczynski e Nower (2002), que, ao propor um modelo dos caminhos que levam ao jogo patológico, apontam que o ambiente no qual as pessoas se encontram e a facilidade de acesso ao jogo facilitam o vício. Disso se entende que o ambiente também importa na recuperação.

Quanto à moradia, porém, as fontes divergem. De um lado, a Nota Técnica (BRASIL, 2025a, p. 9) informa que a moradia da Unidade de Acolhimento é transitória, de até 6 meses, com acolhimento terapêutico e protetivo. Do outro, Jason e Ferrari (2010), pesquisadores da DePaul University que estudam as Oxford Houses, mostram que esse modelo funciona por meio de autogestão, sem prazo de estadia e sem equipe profissional, com permanência média de 10,1 meses, ou seja, mais que os 6 meses. Ao comentar as comunidades terapêuticas, os autores alertam que o prazo limitado pode fazer com que a pessoa volte ao ambiente de risco, porém reconhecem que nenhum modelo serve para todos.

No campo da arquitetura, Hertzberger (1999), arquiteto holandês, relativiza o papel do projeto: para ele, o espaço sozinho não garante a convivência. O arquiteto não controla o comportamento das pessoas; o que ele pode fazer é criar oportunidades para que isso aconteça.

Diante disso, este trabalho se situa em um modelo híbrido de moradia transitória sem prazo fixo, que combina a autogestão das Oxford Houses com a articulação com a rede de saúde do SUS. Propõe-se um equipamento que trata o jogo como um problema coletivo e de saúde pública, e não apenas de responsabilidade individual, e que reúne, num mesmo lugar, a prevenção aberta à comunidade e uma rotina de trabalho, convivência e aprendizado. Seu espaço busca estimular a aproximação com liberdade, permitindo que a pessoa permaneça sem ser obrigada a participar.

5. Conceitos estruturantes

Este trabalho se estrutura em três conceitos: autogestão, educação dialógica e forma convidativa. Os dois primeiros tratam de como se aprende, e o terceiro trata do espaço onde esse aprendizado acontece.

O primeiro conceito é a autogestão. Segundo Jason e Ferrari (2010), pesquisadores que estudam as Oxford Houses, nela aprende-se a viver em recuperação no dia a dia da moradia, com pessoas em situação semelhante e com o mesmo problema. Sem equipe profissional, os próprios moradores criam as regras da casa e aprendem a se governar (JASON; FERRARI, 2010). Aplicado ao centro, esse conceito orienta a moradia transitória a favorecer o afastamento do ambiente de risco e a autonomia gradual de quem está em recuperação, com os moradores participando da gestão da casa.

O segundo conceito é a educação dialógica. Segundo o educador Paulo Freire (1994, p. 39), ninguém aprende sozinho: “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. O autor opõe essa ideia à educação “bancária”, na qual “a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 1994, p. 33). No diálogo, ao contrário, “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa” (FREIRE, 1994, p. 39). Disso se entende que é preciso haver pessoas diferentes, que sabem coisas diferentes, e um espaço de educação para que isso aconteça. Na educação financeira, isso significa não apenas transmitir regras a quem está endividado, mas também aprender com a experiência de quem passou pelo problema. Aplicado ao

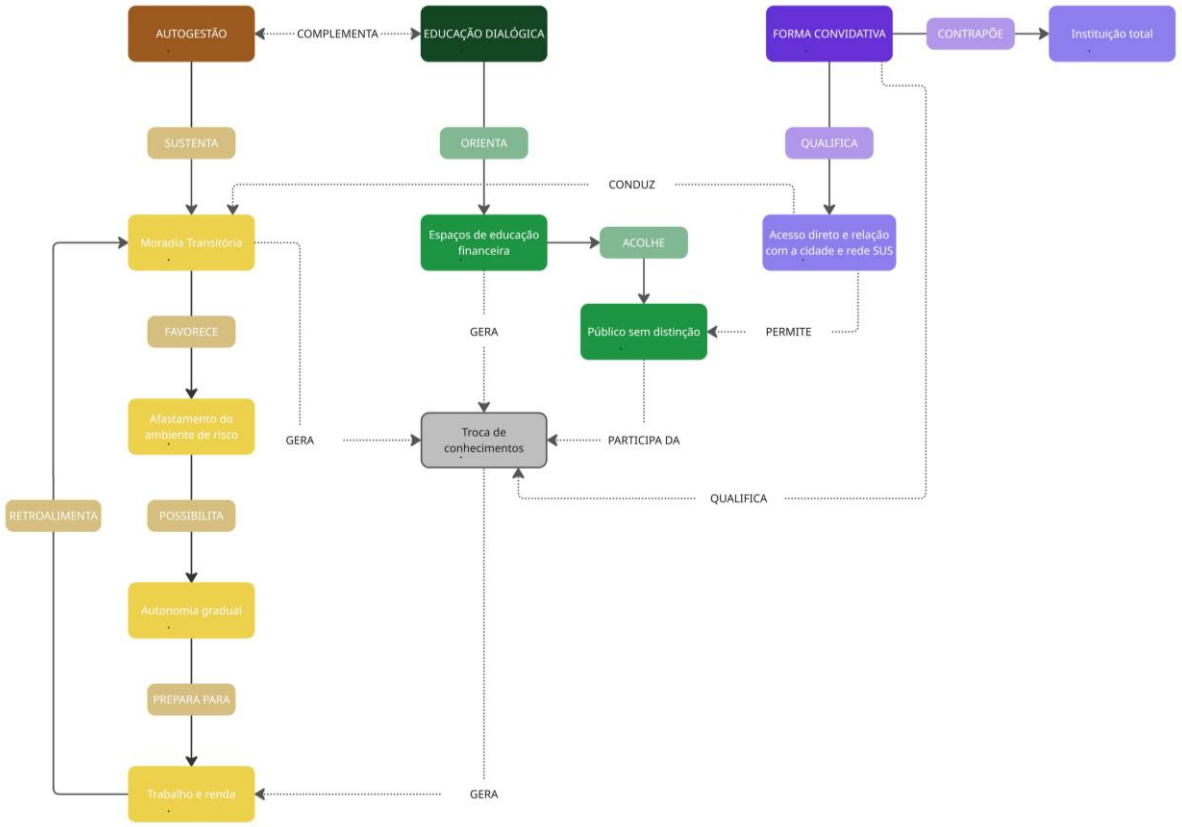
centro, esse conceito orienta os espaços abertos de educação financeira a acolher o público em geral, sem distinguir quem está em recuperação de quem não está. Assim, enquanto a autogestão se apoia em pessoas em situação semelhante e com o mesmo problema, a educação dialógica se apoia em pessoas diferentes, que sabem coisas diferentes.

O terceiro conceito é a forma convidativa, Segundo o arquiteto Herman Herman Hertzberger (1999), o espaço não serve só para ser confortável, mas deve estimular a pessoa a usar, ficar e participar. Quanto mais regras e controles, menos as pessoas se sentem à vontade; o oposto faz com que se envolvam mais, pois, com liberdade, ficam mais motivadas. Para que as pessoas se sintam à vontade para se aproximar de forma espontânea, precisam saber que podem ir embora quando quiserem: “Para que o contato possa se estabelecer espontaneamente é indispensável certa informalidade, certo descompromisso. É a certeza de que podemos interromper o contato ou nos retirarmos quando quisermos que nos encoraja a prosseguir” (HERTZBERGER, 1999, p. 178). O oposto disso é a instituição total, cujo isolamento está no próprio esquema físico, com “portas fechadas, paredes altas” (GOFFMAN, 1974, p. 16). Aplicado ao centro, esse conceito orienta um espaço com acesso direto, sem encaminhamento prévio, onde quem está em recuperação e quem não está possam se aproximar e se afastar livremente, sem distinção.

6. Síntese interpretativa

Para responder à pergunta de como o espaço pode reunir o cuidado hoje fragmentado, este trabalho articula três conceitos. A autogestão sustenta a moradia transitória, onde cada um aprende com seus iguais, pessoas que perderam coisas importantes. A educação dialógica orienta as áreas de educação, que recebem pessoas de fora que querem aprender mais. Com isso, existe uma troca de conhecimentos: um ensina pelo que perdeu, enquanto o outro ensina o que o levou a buscar conhecimento sem ter passado pelo processo de perda. Essa troca gera trabalho e renda, e quem se recuperou volta a orientar quem chega, retroalimentando a moradia. A forma convidativa qualifica essa troca, ao permitir que as pessoas se aproximem e se afastem livremente, e contrapõe a instituição total, fechada e isolada.

7. Diagrama Conceitual



8. Referências

BLASZCZYNSKI, A.; NOWER, L. A pathways model of problem and pathological gambling. **Addiction**, v. 97, n. 5, p. 487-499, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. **Nota Técnica nº 4/2025-CORAP/CGESMAD/DESMAD/SAES/MS**: recomendações para gestores e profissionais de saúde da Rede de Atenção Psicossocial no cuidado integral às pessoas com problemas relacionados a jogos de aposta. Brasília: Ministério da Saúde, 2025a. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2025/nota-tecnica-no-4-2025-corap-cgesmad-desmad-saes-ms.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. **Guia de cuidado para pessoas com problemas relacionados a jogos de apostas**: orientações práticas para o acolhimento, acompanhamento e cuidado de pessoas com problemas relacionados a jogos de apostas, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) e das ações intersetoriais. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2026/guia-de-cuidado-para-pessoas-com-problemas-relacionados-a-jogos-de-apostas.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 1173/2025 – Plenário**. Relatório de levantamento sobre jogos de apostas online (bets) e saúde mental. Processo TC 024.852/2024-4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. Brasília, DF, 28 maio 2025b. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/AC/11/6D/7C/5D817910E5B0C269F18818A8/024.852-2024-4-JPJ-%20Jogos%20de%20Apostas%20online-BETS.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

GOFFMAN, E. **Manicômios, prisões e conventos**. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: Perspectiva, 1974.

HERTZBERGER, H. **Lições de arquitetura**. Tradução de Carlos Eduardo Lima Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

JASON, L. A.; FERRARI, J. R. Oxford House recovery homes: characteristics and effectiveness. **Psychological Services**, v. 7, n. 2, p. 92-102, 2010. DOI: 10.1037/a0017932.

LARANJEIRA, R. R.; MADRUGA, C. S. (coord.). **Caderno temático LENAD III**: jogos de aposta na população brasileira: resultados 2023. São Paulo: UNIFESP, 2025. Disponível em: https://lenad.uniad.org.br/cadernos-lenad/Caderno-Jogos-de-Aposta-LENAD-III.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

WARDLE, H. et al. The Lancet Public Health Commission on gambling. **The Lancet Public Health**, v. 9, n. 11, p. e950-e994, 2024.